# Resumo de Véspera de Psiquiatria

Nov 9, 2026 · @Luis Augusto Lobão Mendes

O essencial das 13 aulas para ler em cerca de 1 hora antes da prova: critérios com tempo, primeira linha com dose, proibições e diferenciais.

## Aulas 1 e 2. Exame do estado mental

**Roteiro:** identificação, QP (queixa principal) e HMA (história da moléstia atual), antecedentes psiquiátricos (remédios, doses, internações, tentativas de autoextermínio), história pessoal, familiar e social, EEM (exame do estado mental). No EEM se descreve o **afeto observado**, não o humor referido.

| Função | O que cai na prova |
|---|---|
| Consciência | Alerta = acordado e responde; lúcido = pensa com clareza. Delirium: **AFOC** (Atenção prejudicada, Flutuação, Orgânico sempre, Ciclo sono e vigília invertido, piora noturna); é emergência clínica. Estado crepuscular: age no automático e tem amnésia lacunar (zolpidem, blackout, epilepsia, TCE). |
| Orientação | Autopsíquica alterada sugere psiquiátrico; alopsíquica (tempo, espaço) sugere orgânico. |
| Atenção | Pares normais: hipotenaz com hipervigil, hipertenaz com hipovigil. Exceções: **depressão = tudo hipo; mania = tudo hiper**. |
| Memória | Anterógrada (Alzheimer inicial) x retrógrada (TCE). Confabulação: preenche lacunas sem mentir (demência, Korsakoff). Hipermnésia: trauma e mania. |
| Linguagem | Ecolalia repete o outro; palilalia repete a si. Neologismo e salada de palavras: esquizofrenia. Mussitação e solilóquio: resposta a vozes. |
| Afeto | Hipermodulado, normomodulado, hipomodulado, embotado (esquizofrenia grave). Lábil oscila; incontinência não consegue conter. |

| Função | O que cai na prova |
|---|---|
| Pensamento | Curso: acelerado (mania), lentificado (depressão), bloqueio e roubo (esquizofrenia). Forma: fuga de ideias (mania); afrouxamento, descarrilhamento e desagregação, em gravidade crescente. Mágico: TOC. |
| Juízo | Ideia sobrevalorada mantém vínculo com a realidade; delírio é certeza irremovível. Persecutório é o mais comum; influência fere a consciência do eu. Cotard: "estou morto". Ekbom: bichos no corpo. |
| Sensopercepção | Alucinação: sem objeto, sem crítica. Ilusão: objeto real distorcido. Alucinose: sem objeto, com crítica, sugere orgânico (Charles Bonnet, abstinência alcoólica). Visual em psiquiátrico primário: investigar neurológico. |
| Vontade | Hipobulia e abulia. **Impulso busca prazer imediato; compulsão alivia ansiedade.** |
| Psicomotricidade | Cataplexia: perde o tônus e cai (narcolepsia). Catalepsia: mantém a pose (catatonia). Catatonia: negativismo, estupor, ecos, obediência automática. |

# Aula 3. Depressão

**Diagnósticos:**

- **TDM (Transtorno Depressivo Maior):** 5 ou mais sintomas por **2 semanas**, sendo obrigatório humor deprimido ou anedonia. Demais: sono, culpa, energia, concentração, apetite e peso, psicomotor, ideias de morte.
- **Distimia:** humor deprimido por **2 anos**, sem passar mais de 2 meses bem, mais 2 sintomas.
- **TDPM (Transtorno Disfórico Pré-Menstrual):** 5 sintomas, sendo 1 afetivo, de 1 semana antes a 1 semana depois da menstruação.
- **Luto:** se o prejuízo passar de cerca de 2 semanas, investigar TDM ou luto prolongado.

**Fisiopatologia em uma frase:** herdabilidade de 37% (alelo S do transportador de serotonina), menos monoaminas, receptores e transdução alterados, BDNF baixo pelo cortisol crônico (atrofia de hipocampo), inflamação (IL-6, TNF-α, PCR), disbiose e tríade

negativa de Beck (eu, mundo, futuro). Perfil inflamatório: lentidão, amotivação, queixa cognitiva, ansiedade e PCR maior que 3, pede estratégia dopaminérgica.

**Alvo pelo sintoma:** afeto negativo = serotonina; anergia e desmotivação = dopamina; pouco interesse e concentração = noradrenalina.

| Fármaco | Dose | Guardar |
|---|---|---|
| Fluoxetina | 20 a 80 mg | SUS, infância e gestação, meia-vida longa |
| Sertralina | 50 a 200 mg | Gestação e amamentação, poucas interações, coração |
| Escitalopram | 10 a 20 mg | Máx. 15 mg acima de 85 anos (citalopram máx. 30 mg) |
| Paroxetina | 20 a 60 mg | Mais ganho de peso e disfunção sexual |
| Fluvoxamina | 100 a 300 mg | TOC |
| Venlafaxina | 75 a 225 mg | Dual só a partir de cerca de 150 mg; hipertensão; retirada |
| Desvenlafaxina | 50 a 200 mg | Poucas interações; fogachos |
| Duloxetina | 60 a 120 mg | Dor neuropática; cuidado hepático e com álcool |
| Bupropiona | 150 a 300 mg | Dopamina e noradrenalina; tabagismo; poupa a vida sexual |
| Mirtazapina | 30 a 45 mg | Antagonista alfa 2; sono e ganho de peso |
| Trazodona | 25 a 150 mg (sono); 150 a 375 mg (depressão) | Insônia e ansiedade |
| Vortioxetina | 10 a 20 mg | Queixa cognitiva; náusea |
| Agomelatina | 25 a 50 mg | Ritmo circadiano; monitorar fígado |
| Tricíclicos | 75 mg ou mais | Clomipramina no TOC; cuidado com coração, convulsão, idoso |

**ISRS:** demoram 6 a 8 semanas porque os autorreceptores precisam se dessensibilizar. Efeitos: hiponatremia, QTc, sangramento, embotamento, disfunção sexual.

**Depressão resistente:** antipsicótico potencializador (aripiprazol, quetiapina e outros); lítio (antissuicídio); **ECT** (refratária, intolerância, risco iminente de suicídio; reduz ideação em 81% ao final; sem contraindicação absoluta); **escetamina** (antagonista NMDA, sempre com antidepressivo, ambiente controlado).

**Psicoterapias:** TCC (Terapia Cognitivo Comportamental) com reestruturação; ativação comportamental (agir antes da motivação); interpessoal (luto, disputas, mudança de papel, déficits).

## Aulas 4 e 5. Bipolar e comportamento suicida

**Tempos (macete 7, 4, 14):** mania 7 dias (ou qualquer duração se internar); hipomania 4 dias; depressão 14 dias. Psicose ou internação = mania. Sintomas maniformes: humor elevado ou irritável mais 3 (4 se só irritável): grandiosidade, menos sono sem cansaço, loquacidade, fuga de ideias, distraibilidade, mais atividade, gastos e sexo de risco.

- **Tipo I:** 1 mania basta. **Tipo II:** hipomania mais depressão, nunca mania. **Ciclotimia:** 2 anos de oscilações incompletas; até 50% viram TAB.
- **Misto:** os dois polos juntos, mais grave. **Ciclagem rápida:** 4 ou mais episódios em 12 meses.
- **Neuroprogressivo:** cada episódio lesa (dopamina, glutamato, inflamação, BDNF baixo, falha mitocondrial); pode chegar a déficit tipo demência.
- **TAB x borderline:** dias a semanas e sem gatilho x horas e reativo a abandono. **TAB x TDAH:** episódico com menos necessidade de sono x contínuo desde a infância, precisa dormir.
- Suicídio 15 vezes maior; letalidade maior no **tipo II**; risco com ciclagem rápida, misto, tentativa prévia e história familiar.

**Lítio:** padrão ouro com a quetiapina (todas as fases), neuroprotetor e antissuicídio. Litemia **1,0 mEq/L na mania**, coletada **12 horas** após a dose, 1 semana após iniciar; semanal até estabilizar, mensal por 2 a 3 meses, depois trimestral. Exames trimestrais: litemia, TSH, creatinina, cálcio. **Diuréticos, AINE e IECA elevam a litemia.** Poliúria: investigar diabetes insípido.

| Fármaco | Uso | Dose e cuidado |
|---|---|---|
| Lamotrigina | Só depressão bipolar | 25 mg, sobe a cada 2 semanas até 200 a 400 mg; rash; virada maníaca |
| Valproato | Mania, ciclagem rápida, misto | 250 mg, sobe a cada 2 dias até 750 a 1800 mg; teratogênico, rash suspende |

| Fármaco | Uso | Dose e cuidado |
|---|---|---|
| Carbamazepina | Mania, segunda linha | Muitas interações; não serve para depressão |
| Lurasidona | Depressão bipolar | Com lítio no predomínio depressivo |

**Nunca:** lamotrigina com valproato (Stevens Johnson); antidepressivo de manutenção no TAB (ciclagem e misto). Olanzapina com fluoxetina só em terceira linha.

### Suicídio

- **Escada:** ideação de morte (passiva), ideação suicida (ativa), desejo, intenção, planejamento, tentativa, suicídio.
- **Estados mentais (AIR):** Ambivalência (janela para intervir), Impulsividade, Rigidez de pensamento.
- **Homem consuma, mulher tenta.** Jovens de 15 a 30 anos e idosos; desemprego (3 primeiros meses), viver só, acesso a meios letais.
- 90% têm transtorno mental (risco cerca de 8 vezes). **TDM lidera em números absolutos; TAB no risco proporcional.**
- **Perguntar não induz.** Avaliar intenção, plano, meios, fatores protetores e suporte; risco alto com desesperança, tentativa prévia, estado misto, recusa ao tratamento, arma de fogo.
- **Após tentativa:** acolher, estabilizar e **notificar no SINAN**.
- Prevenção: restringir pesticidas (cerca de 20% dos suicídios) e armas, embalagens menores, mídia sem detalhar método. Fármacos: lítio, ECT, escetamina. Setembro Amarelo: 10 de setembro.

## Aula 6. Psicoses

**Cinco domínios:** delírio, alucinação, pensamento desorganizado, comportamento desorganizado ou catatônico, sintomas negativos (afeto diminuído, avolição e apatia, associabilidade, alogia, anedonia, pensamento concreto, prejuízo cognitivo).

**Esquizofrenia:** 2 ou mais domínios por 1 mês, com **1 nuclear** (delírio, alucinação ou pensamento desorganizado); queda funcional em relação ao próprio nível prévio; **6 meses** de sinais contínuos. Breve: menos de 1 mês, com remissão; esquizofreniforme: 1 a 6 meses.

- **Morte:** cardiovascular precoce (tabaco, sedentarismo, dieta, antipsicótico); 25% a 50% tentam suicídio e cerca de 10% consumam.
- **Prognóstico:** pior com DUP (duração da psicose não tratada) longa, início precoce e personalidade esquizoide; decisivos os primeiros 5 anos.

- **Delirante:** delírio por 1 mês, nunca critério A; prejuízo só no tema do delírio; persecutório; cerca de 0,2%.
- **Esquizoafetivo:** episódio de humor com psicose mais **2 semanas de psicose sem humor**; tipos bipolar e depressivo.
- **Catatonia na depressão:** mais negativismo e sem flexibilidade cérea.

| Via dopaminérgica | Na psicose | Bloqueio D2 causa |
|---|---|---|
| Mesolímbica | Excesso, sintomas positivos | Melhora dos positivos |
| Mesocortical | Falta, sintomas negativos | Piora dos negativos em dose alta |
| Nigroestriatal | Normal | Extrapiramidais |
| Tuberoinfundibular | Normal | Hiperprolactinemia e galactorreia |

**Atípicos** bloqueiam também o 5-HT2A, que libera dopamina no pré-frontal: menos extrapiramidais, menos prolactina e menos piora dos negativos.

| Fármaco | Dose ou uso | Guardar |
|---|---|---|
| Haloperidol | Oral, IM imediato, depósito a cada 2 a 4 semanas | Alta potência, extrapiramidal, SUS |
| Clorpromazina, levomepromazina | Baixa potência | Sedação, hipotensão, anticolinérgico |
| Risperidona | 1 a 8 mg | "Mais típico dos atípicos" |
| Olanzapina | 5 a 20 mg | Seda e engorda |
| Ziprasidona | 80 a 160 mg | Com refeição de 500 kcal; bom perfil metabólico |
| Quetiapina | 400 a 800 mg | Baixa afinidade D2; dose baixa só seda (H1); TAB todas as fases, gestante bipolar, delirium |
| Aripiprazol | Agonista parcial D2 | Bom metabólico; **acatisia** |
| Clozapina | Refratária após 2 antipsicóticos | Agranulocitose: hemograma semanal 18 semanas, quinzenal 18 semanas, depois mensal; constipação |

**Refratário à clozapina:** ECT de manutenção. **Discinesia tardia** (mais de 1 ano de uso): trocar para clozapina. **Síndrome neuroléptica maligna:** febre, rigidez, consciência flutuante, instabilidade autonômica, rabdomiólise e leucocitose; suporte intensivo.

## Aulas 7 e 8. Ansiedade e TOC

Medo = ameaça real e imediata; ansiedade = antecipação do futuro. Todos os ansiosos têm a preocupação como base; muda o foco.

| Transtorno | Núcleo | Tempo | Tratamento-chave |
|---|---|---|---|
| TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizada) | Preocupação com vários temas, mais 3 sintomas (tensão, irritabilidade, concentração, fadiga, inquietação, sono) | 6 meses | Leve: TCC; moderado: TCC ou fármaco; grave: ambos. ISRS (escitalopram, sertralina, paroxetina), IRSN, pregabalina. Reavaliar em 4 a 6 semanas; manter 6 a 12 meses sem reduzir a dose |
| Pânico | Ataques inesperados recorrentes; medo do próximo ataque | 1 mês após um ataque | ISRS, venlafaxina, ADT; BZD só no início ou resgate; TCC contra a esquiva. Buspirona não funciona |
| Agorafobia | 2 de 5 situações: aberto, transporte, fechado, multidão, sair sozinho | 6 meses | Exposição gradual; no idoso, descartar medo real de queda |
| Ansiedade social | Avaliação negativa: interação, observação, desempenho | | TCC, habilidades sociais, exposição, vídeo; antidepressivo |
| Fobia específica | Animal, ambiente natural, sangue e injeção, situacional, outro | 6 meses | **Exposição**; sem fármaco específico; sangue e injeção com paciente deitado (vasovagal) |

**Ataque de pânico:** pico em minutos, **4 ou mais sintomas** de 14 (coração, falta de ar, náusea, tontura, sudorese, tremor, parestesia, desrealização, despersonalização, medo de morrer ou enlouquecer); dura 40 minutos a 1 hora. Menos de 4 = crise de ansiedade.

Sempre excluir causa orgânica: cardíaca, respiratória, metabólica, intoxicação, abstinência.

**Fármacos ansiolíticos:**

- **Pregabalina:** liga a subunidade α2δ do canal de cálcio e reduz glutamato; não age em GABA; age rápido; ajuste renal; tontura, sonolência, quedas.
- **Buspirona:** agonista parcial 5-HT1A; semanas de latência; sem dependência; serve para bruxismo por ISRS.
- **BZD (benzodiazepínicos):** potencializam o GABA-A (mais cloro, hiperpolarização). α1 seda (zolpidem), α2 e α3 acalmam, α5 prejudica a cognição. **Lorazepam no hepatopata**; diazepam na convulsão e abstinência alcoólica. Curto prazo.
- **Retirada x recaída:** dias após parar x semanas, com volta dos sintomas.

### TOC

- **Obsessão:** intrusiva e **egodistônica**; tentar suprimir aumenta (rebote). **Compulsão:** ritual que alivia; o alívio é **reforço negativo** e mantém o ciclo.
- Padrões: contaminação (lavagem), dúvida (verificação), pensamentos intrusivos (compulsões mentais), simetria (lentidão).
- Insight bom, pobre ou ausente. 1% a 3%; 17 anos de atraso; comorbidade em 90%; obsessões sexuais e religiosas aumentam o risco de suicídio.
- Neurobiologia: serotonina baixa, dopamina alta, glutamato alto.
- **Tratamento:** exposição com prevenção de resposta (não fazer o ritual; desfazer a fusão pensamento e ação); **ISRS em dose alta por 12 a 20 semanas**; clomipramina; antipsicótico adjuvante (risperidona, aripiprazol); memantina ou lamotrigina; cirurgia nos refratários. Orientar a família a não acomodar os rituais.
- **Espectro:** Tourette (vários tiques motores e 1 vocal por mais de 1 ano, início antes dos 18); dismórfico (defeito imperceptível, não é peso); acumulação (insight ausente, piora após os 55); tricotilomania e escoriação (reversão de hábitos e N-acetilcisteína acima de 2 g).

## Aulas 9 e 10. Trauma, somatoformes e dissociativos

**TEPT (Transtorno de Estresse Pós-Traumático), macete "1, 1, 1, 2, 2":** exposição a morte, lesão grave ou violência sexual (vivida, testemunhada, de pessoa próxima ou por detalhes repetidos, como socorristas); 1 intrusivo (lembranças, pesadelos, flashbacks, reação a gatilhos); 1 esquiva; 2 de humor e cognição (amnésia dissociativa, culpa, crenças negativas, sem afeto positivo); 2 de hiper-reatividade (hipervigilância, sobressalto, irritabilidade, imprudência, concentração, sono).

- **TEPT complexo** (CID-11, não está no DSM): trauma prolongado sem fuga; acrescenta desregulação emocional, autoimagem negativa e prejuízo relacional; pior prognóstico.
- **Tratamento:** exposição prolongada (primeira escolha; 30% a 35% abandonam), processamento cognitivo, exposição escrita, EMDR. **ISRS** primeira escolha. Doxazosina ou prazosina para pesadelos; propranolol para hiper-reatividade.
- **BZD proibido no 1º mês:** apaga a resposta autonômica, mas não o estresse, e a memória se hiperconsolida no hipocampo. Na insônia aguda: quetiapina, trazodona, anti-histamínico.
- **Adaptação:** sintomas em até **3 meses** do estressor e somem em até **6 meses** após ele cessar.
- **Luto prolongado:** 12 meses (adultos) ou 6 (crianças); saudade ou preocupação mais 3 sintomas; terapia de Katherine Shear (16 sessões).
- **Infância:** apego reativo (retraído, não busca conforto, antes dos 5 anos, excluir TEA) x interação social desinibida (vai com estranhos, não é TDAH). Tratamento: cuidador estável.

| Quadro | De propósito? | Ganho externo? | Ponto-chave |
|---|---|---|---|
| Sintomas somáticos | Não | Não | Sintoma com pensamento, ansiedade e tempo excessivos; consultas programadas, TCC |
| Ansiedade de doença | Não | Não | Medo da doença com sintoma mínimo, 6 meses; busca ou evita cuidado |
| Conversivo | Não | Ganho secundário inconsciente | Sinal motor ou sensorial incompatível com a neurologia; diagnóstico de exclusão |
| Factício (Munchausen) | Sim | Não | Fraude comprovada para ser doente; profissional de saúde, múltiplas internações |
| Simulação | Sim | Sim | Não é transtorno |

- **CNEP (Crise Não Epiléptica Psicogênica):** movimento de quadril, olhos fechados, grito no meio, duração longa; **vídeo EEG é o padrão ouro**. Exame normal não basta para excluir doença orgânica.
- **Ganho primário** produz o sintoma; **secundário** o mantém. La belle indifférence sugere, mas não é critério.

- **Dissociativo de identidade:** 2 ou mais identidades com lacunas de memória; trauma infantil, redes neurais com inibição cruzada. Sugerem simulação: identidades caricatas, orgulho, amnésia conveniente, incentivo externo.
- **Amnésia dissociativa:** bloqueio de memória autobiográfica (localizada, seletiva, generalizada); fuga dissociativa como especificador; excluir causas neurológicas e substâncias. Recuperar a memória não é obrigatório; hipnose é controversa.
- **Despersonalização** (o eu estranho) e **desrealização** (o mundo estranho), com **juízo de realidade preservado**; TCC, ISRS, lamotrigina.

# Aulas 11 a 13. Personalidade, alimentares e dependências

## Personalidade

Traço é flexível; transtorno é rígido, com início no fim da adolescência. Big Five: OCEAN (abertura, conscienciosidade, extroversão, amabilidade, neuroticismo).

| Cluster | Transtorno | Núcleo |
|---|---|---|
| A, esquisitos | Paranoide | Desconfiança, rancor, sem psicose persistente |
| A | Esquizoide | Isola-se por desinteresse genuíno (no TEA há desejo de interagir) |
| A | Esquizotípico | Excentricidade, pensamento mágico; espectro da esquizofrenia |
| B, dramáticos | Antissocial | Quer **vantagem**; sem remorso; empatia cognitiva preservada; até 70% nas prisões |
| B | Narcisista | Quer **admiração**; autoestima frágil |
| B | Histriônico | Quer **atenção** |
| B | Borderline | Teme **abandono**; idealiza e desvaloriza; impulsividade, vazio, automutilação |
| C, ansiosos | Evitativo | Teme crítica, mas deseja vínculo |
| C | Dependente | Teme ficar sem cuidado |
| C | Obsessivo compulsivo | Perfeccionismo, controle, rigidez |

**Tratamento:** psicoterapia é a base. Cluster A: antipsicótico. Antissocial: sem tratamento eficaz; valproato ou antipsicótico para agressividade. **Borderline: TCD (Terapia Comportamental Dialética); fármacos só sintomáticos; nunca BZD.** Cluster C: melhor

resposta à psicoterapia; ISRS no evitativo.

## Transtornos alimentares

| | Anorexia | Bulimia | Compulsão alimentar |
|---|---|---|---|
| Núcleo | Restrição, medo de engordar, imagem distorcida | Compulsão mais compensação | Perda de controle sem compensação |
| Peso | Baixo (normal na atípica) | Normal ou oscilante | Metade não é obesa |
| Frequência | Subtipo pelos últimos 3 meses | 1 vez por semana por 3 meses | 1 vez por semana por 3 meses |
| Fármaco | Olanzapina (sem aprovação) | **Fluoxetina 60 mg** (único aprovado pela FDA) | **Lisdexanfetamina** (único aprovado pela FDA) |
| Psicoterapia | TCC focada; terapia familiar em jovens | TCC, padrão ouro | TCC ou interpessoal, primeira linha |

- **Gravidade da AN pelo IMC:** leve 17 ou mais; moderada 16; grave 15; extrema menos de 15. Compulsão e bulimia por episódios semanais: 1 a 3, 4 a 7, 8 a 13, 14 ou mais.
- **Realimentação** (por volta do 4º dia): a insulina joga fósforo, potássio e magnésio para dentro das células; **hipofosfatemia** com arritmia e insuficiência respiratória; retenção hídrica; falta de tiamina leva a Wernicke. Começar com 5 a 20 kcal/kg/dia e monitorar eletrólitos e ECG.
- AN: complicações cardíacas em até 80%; internar se desnutrição grave, eletrólitos alterados, bradicardia, instabilidade ou risco de suicídio.
- **Vômito causa alcalose; laxante causa acidose.** Hipocalemia, erosão dentária, parótidas aumentadas, Mallory-Weiss.
- **Bupropiona é proibida na bulimia** (convulsão).
- Fissura dura cerca de 20 minutos; evitar jejum e dieta rígida. Investigar compulsão antes da cirurgia bariátrica.

## Dependências

- **Uso nocivo:** dano pelo efeito no contexto (pouco álcool e acidente). **Abusivo:** dano pelo padrão ou condição clínica (gestante, cirrótico).
- **11 critérios:** perda de controle, compromissos sociais, uso de risco, tolerância e abstinência. Gravidade: **2 a 3 leve, 4 a 5 moderada, 6 ou mais grave**.

- Potencial aditivo maior com via rápida (inalatória), meia-vida curta (crack, midazolam) e dose alta. Genética dos receptores D2; TDAH aumenta o risco de cocaína.
- **Dopamina sinaliza relevância, não prazer**, e é liberada na decisão. Erro de previsão: recompensa maior gera pico; menor gera queda. Adolescente: recompensa reativa com pré-frontal imaturo.
- Depressores (álcool, opioides, solventes, BZD; efeito bifásico), perturbadores (maconha, LSD), estimulantes (cocaína, crack, anfetaminas).
- Reforço positivo (impulsivo, busca prazer) evolui para reforço negativo (compulsivo, evita sofrimento).
- **Estágios de mudança:** pré-contemplação, contemplação (ambivalência), preparação, ação, manutenção, recaída (não é fracasso), término.
- **Entrevista motivacional:** empatia, discrepância, evitar argumentação, acompanhar a resistência, autoeficácia.
- Internação voluntária funciona melhor; involuntária só com risco à vida; nunca como punição. Redução de danos não se opõe à abstinência.

## Última olhada antes de entrar na sala

**Régua dos tempos:**

| Tempo | Quadros |
|---|---|
| 4 dias | Hipomania |
| 7 dias | Mania |
| 2 semanas | TDM; psicose isolada no esquizoafetivo |
| Menos de 1 mês | Psicótico breve |
| 1 mês | Transtorno delirante; pânico após um ataque |
| 3 meses | Compulsão e bulimia (1 vez por semana); início da adaptação |
| 1 a 6 meses | Esquizofreniforme |
| 6 meses | Esquizofrenia, TAG, agorafobia, fobia, ansiedade de doença; limite da adaptação após o estressor |
| 12 meses | Luto prolongado em adultos (6 meses em crianças) |
| Mais de 1 ano | Tourette e tique persistente |
| 2 anos | Distimia e ciclotimia |

**O que nunca fazer:**

- Bupropiona na bulimia.
- Lamotrigina com valproato.
- BZD no primeiro mês após trauma e no borderline.
- Valproato em mulher fértil sem controle.
- Antidepressivo de manutenção no TAB.
- Internar dependente como punição.

**Únicos aprovados:** fluoxetina na bulimia; lisdexanfetamina na compulsão alimentar; lamotrigina só na depressão bipolar; lítio e quetiapina em todas as fases do TAB; clozapina na esquizofrenia refratária.

**Pares que mais confundem:**

| Par | O que separa |
|---|---|
| Impulso x compulsão | Prazer imediato x alívio da ansiedade |
| Ideia sobrevalorada x delírio | Algum vínculo com a realidade x certeza irremovível |

| Par | O que separa |
|---|---|
| Alucinação x alucinose | Sem crítica x com crítica (orgânico) |
| TAB x borderline | Dias a semanas, sem gatilho x horas, reativo a abandono |
| Esquizoafetivo x humor psicótico | Psicose sozinha por 2 semanas x psicose só dentro do episódio |
| Esquizofrenia x delirante | Queda global x prejuízo só no tema |
| Conversivo x factício x simulação | Involuntário x intencional sem ganho x intencional com ganho |
| Anorexia x bulimia | Não comer e peso baixo x ciclo compulsão e compensação |
| Nocivo x abusivo | Efeito no contexto x padrão ou condição clínica |
| Retirada x recaída | Dias x semanas |

**Três regras que resolvem muitas questões:**

1. Diante de quadro agudo, flutuante ou com alucinação visual, **exclua causa orgânica** antes de pensar em transtorno primário.
2. Ritual, esquiva e substância se mantêm por **reforço negativo**; o tratamento é expor sem deixar a resposta acontecer.
3. Sempre **pergunte sobre suicídio** e notifique a tentativa no SINAN.

*Fonte: Masterclass de Psiquiatria, baseada nas apostilas das Aulas 1 a 13 (Mariana Freitas, turma 79A).*